

Incision de la plaque et greffe

WARWIKI

Information pour le patient · Chirurgie pour redresser le pénis (maladie de La Peyronie)

La maladie de La Peyronie provoque une cicatrice (plaque) à l'intérieur du pénis qui peut le courber lors d'une érection, rendant parfois les rapports difficiles. Dans cette chirurgie, la cicatrice du côté court et tendu est incisée (et parfois partiellement retirée) pour libérer la courbure, et l'espace est comblé par une greffe. Cette fiche explique le fonctionnement, la préparation et ce à quoi vous attendre.

À propos de cette intervention

Une plaque de tissu cicatriciel tire un côté du pénis, ce qui le courbe lors d'une érection. L'opération libère la courbure en incisant la cicatrice du côté **court (interne)** ; cela ouvre un espace comblé par une **greffe** — un fin patch (patch de collagène, tissu donneur/animal, ou tissu de votre propre corps). En allongeant le côté court plutôt qu'en raccourcissant le côté long, elle **préserve la longueur du pénis**.

Elle est indiquée quand :

- La courbure est **sévère ou complexe** (ex. : forme en sablier ou en charnière)
- Conserver la **longueur** est important (la plication raccourcirait trop)
- Les **érections sont suffisamment fermes** pour supporter cette opération

Ce qu'il faut savoir

L'avantage est que la **longueur est préservée** (parfois légèrement augmentée). La contrepartie est un **risque plus élevé de dysfonction érectile** (nouvelle ou aggravée) qu'avec la plication — car le travail sur la cicatrice peut affecter la façon dont le pénis retient le sang — donc elle n'est proposée que si les érections sont fermes. Un **engourdissement du gland** est fréquent en début de récupération (les nerfs sont délicatement écartés) et disparaît généralement en 6 à 12 mois. La plupart des hommes obtiennent une érection droite permettant les rapports.

COMPRENDRE LES TERMES

Maladie de La Peyronie

Cicatrice dans le pénis qui le courbe lors d'une érection.

Plaque

Zone de tissu cicatriciel à l'origine de la courbure.

Greffe

Patch fin comblant l'espace après libération de la cicatrice — patch de collagène, tissu donneur/animal ou tissu de votre corps.

Érection artificielle

Érection provoquée au bloc opératoire (par injection) pour mesurer et vérifier la courbure.

Circoncision

Ablation du prépuce — souvent réalisée en même temps si vous n'êtes pas déjà circoncis.

Réhabilitation pénienne

Utilisation d'un médicament pour l'érection et/ou d'un dispositif à vide pendant la guérison pour protéger érections et longueur.

Anesthésie générale

Médicament vous maintenant endormi et sans douleur pendant l'opération.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'opération se fait sous anesthésie générale ou rachianesthésie : vous ne sentez rien. Ensuite, le pénis est gonflé, marqué d'ecchymoses et sensible pendant 1 à 2 semaines — glace, soutien et antalgiques aident. Plus longue que la plication (souvent 1 h 30 à 3 h), avec parfois une nuit d'hospitalisation. Une sonde est posée et retirée le lendemain.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Réalisée sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — suivez toutes les consignes (jeûne, médicaments à suspendre, dont les anticoagulants).
- La maladie de La Peyronie doit être **stable** (courbure et douleur stabilisées depuis plusieurs mois) et les **érections évaluées** au préalable — cette chirurgie nécessite une bonne fonction érectile.
- **Ne fumez pas** ; toute infection est traitée au préalable et des antibiotiques vous seront administrés. Si vous n'êtes pas circoncis, une circoncision est souvent réalisée en même temps.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Avez des **érections faibles** ou nécessitez un médicament/des injections pour les érections
- Prenez un anticoagulant ou avez eu une chirurgie pénienne antérieure

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi ou insensible sous anesthésie ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Une **érection est provoquée par injection** pour visualiser la courbure ; la peau est soulevée et les nerfs sur le dessus du pénis délicatement écartés.
- 3 La cicatrice du côté court est **incisée (et parfois partiellement retirée)** pour libérer la courbure, et l'espace est comblé par une **greffe** ; le résultat est vérifié et la peau refermée.

Après la chirurgie

- Gonflement, ecchymoses et sensibilité pendant 1 à 2 semaines. Un **engourdissement du gland** est fréquent et disparaît généralement en quelques mois.
- La sonde est généralement retirée le lendemain matin.
- **Évitez les rapports pendant environ 6 à 8 semaines** pour laisser la greffe cicatriser.
- Votre équipe débutera probablement une **réhabilitation pénienne** (médicament à faible dose et/ou dispositif à vide quotidien) pour protéger érections et longueur.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons, ou une rougeur, douleur, gonflement ou écoulement croissants au niveau de la plaie
- Une impossibilité d'uriner
- Un gonflement ou une douleur sévères ou croissants, ou un saignement abondant

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Cette chirurgie libère la courbure en incisant la cicatrice et en comblant l'espace par une greffe — elle **préserve la longueur**, pour les courbures sévères ou complexes.
2. La contrepartie est un **risque plus élevé de dysfonction érectile** qu'avec la plication ; elle n'est donc proposée qu'avec des érections fermes. Un engourdissement précoce du gland est fréquent et récupère généralement.
3. La maladie doit être stable et les érections évaluées ; ne fumez pas. Après, évitez les rapports ~6 à 8 semaines et suivez la réhabilitation pénienne.